

Check ☒ 1回目 月 日 / 20問

Check ☒ 2回目 月 日 / 20問

Check ☒ 3回目 月 日 / 20問

解答

解説

- × 第3～5頸椎から出る。
-
- 神経筋疾患や開心術などが原因となりうる。
- × 仰臥位で悪化する呼吸困難と奇異性呼吸が特徴である。
- 他に外傷、頸部～腹部の手術の合併症、感染などが原因となる。
- × 後縦隔腫瘍では横隔神経麻痺はみられないことが多いが、時に交感神経の圧迫により **Horner** 症候群を伴うことがある。
立位の撮影では呼気時に腹部の呼吸筋により横隔膜を挙上させることができるが、臥位では横隔膜に対する重力の影響がなくなり横隔神経麻痺を診断しやすくなる。
- × 特に臥位において、肺活量が低下する。
- 両側性の横隔神経麻痺では、最大吸気圧は正常値の65%、最大呼気圧は40%まで低下する。
-
- × 滑脱型食道裂孔ヘルニアの場合にきたしやすい。
- × 抗コリン薬は禁忌である。

IV